

INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE (IRA) CHEZ L'ENFANT

1. DÉFINITION

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est une diminution brutale et réversible de la fonction rénale, caractérisée par une augmentation de la créatininémie et/ou une oligurie ($< 0,5 \text{ mL/kg/h}$ pendant $> 6 \text{ h}$). Chez l'enfant, elle est souvent secondaire à une pathologie infectieuse, déshydratation ou un syndrome hémolytique et urémique (SHU).

2. CLASSIFICATION (KDIGO)

- **Stade 1** : Augmentation de la créatininémie $\geq 1,5$ x la valeur basale ou diurèse $< 0,5 \text{ mL/kg/h}$ pendant 6-12h.
- **Stade 2** : Augmentation ≥ 2 x la valeur basale ou diurèse $< 0,5 \text{ mL/kg/h}$ pendant > 12 h.
- **Stade 3** : Augmentation ≥ 3 x la valeur basale ou créatininémie $\geq 4 \text{ mg/dL}$ ou diurèse $< 0,3 \text{ mL/kg/h}$ pendant > 24 h ou anurie > 12 h.

3. ÉTIOLOGIES CHEZ L'ENFANT

- **IRA prérénale** (hypovolémie) : déshydratation aiguë (gastro-entérite, pertes digestives), choc septique.
- **IRA rénale (parenchymateuse)** : syndrome hémolytique et urémique (SHU), gloméronephrites, néphrites interstitielles, toxiques.
- **IRA post-rénale (obstructive)** : malformations congénitales, valves de l'urètre postérieur, calculs, tumeurs.

4. CLINIQUE

- Signes généraux : irritabilité, fatigue, troubles de la croissance en cas d'évolution prolongée.
- Signes urinaires : oligurie/anurie, hématurie, protéinurie.
- Signes biologiques : hyperkaliémie, acidose métabolique, hyperurémie.

5. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE ET IMAGERIE

- **Bilan sanguin** : urée, créatinine, ionogramme, gaz du sang.
- **Bilan urinaire** : ionogramme urinaire, rapport Na^+/Cr , bandelette.
- **Imagerie** : échographie rénale pour éliminer une obstruction ou une malformation.

6. PRISE EN CHARGE

- Correction de la cause sous-jacente.
- Optimisation volémique : remplissage prudent en cas de déshydratation, restriction en cas de surcharge.
- Contrôle des équilibres hydro-électrolytiques.
- Arrêt des médicaments néphrotoxiques (AINS, aminosides).
- Dialyse si : hyperkaliémie réfractaire, surcharge volémique, acidose sévère, encéphalopathie urémique.

7. PRONOSTIC ET PRÉVENTION

- Pronostic variable selon la cause et la prise en charge.
- Prévention par hydratation suffisante, prise en charge rapide des infections et surveillance des médicaments néphrotoxiques.
- Surveillance néphrologique prolongée pour dépister une insuffisance rénale chronique (IRC) secondaire.